의료진 진료 카드 · ASL-043

경구 3제 후, 다음 치료는?

주사 치료 가능성과 과이화·췌도부전을 먼저 분기한다.

경구 4제는 주사 강화가 어려울 때의 제한적 대안



강화의 기본 원칙

과이화 상태	다음·다뇨·다갈·체중감소 등 증상이 동반되면 HbA1c 9% 도달 전에도 인슐린을 도입한다.
조기 병용	HbA1c ≥7.5% 또는 목표보다 ≥1.5% 높으면 조기 병용요법을 고려한다. 경구약 추가의 HbA1c 강하 효과는 0.5~1.0%p, 주사제는 1.0~2.5%p로 소개되었다.

연자 Q&A · 4번째 경구약 선택

SU 추가	빠른 혈당강하가 필요하고 저혈당 위험이 낮을 때 고려. 저혈당·체중 증가를 함께 평가한다.
TZD 추가	인슐린 저항성이 뚜렷하거나 저혈당을 피하고 싶을 때 고려. 심부전에서는 피한다. SGLT2i 병용 시 말초부종이 상대적으로 덜하다는 연자 의견.

연자 Q&A · 주사 강화의 선택

ASCVD 동반	DPP-4i를 중단하고 심혈관 이득이 입증된 semaglutide·dulaglutide로 교체를 고려한다. 식욕·체중감소와 위장관 내약성을 함께 본다.
기저인슐린 필요	솔리쿠아·줄토피는 경구약/GLP-1 RA만으로 조절이 어렵거나 식사 인슐린 추가 전 단순화할 때의 선택지. 심부전 예후 개선은 SGLT2i 우선이라는 연자 의견.

고령·자가 주사 곤란·말기 동반질환 등으로 주사 치료가 어려운 경우에 경구 4제를 고려한다. 인슐린이 필요한 환자에서 치료적 관성을 유지하는 수단으로 쓰지 않는다.